



RESUMO DE AULA · JORNADA DA LEITURA

Processos atencionais

CAPÍTULO 6

O domínio mais esquecido da clínica — e o mais basal. Da atenção como recurso limitado à atenção como processo treinável, com o looping da dor crônica como fio condutor.

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

Júlio Gonçalves

MSc · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

Comunidade Lógica Psicológica

Uma comunidade para quem quer:

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, com pensamento crítico e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas e construção em rede.

[Clique aqui e saiba mais](#)



O ESSENCIAL

- Ψ **Processos básicos são o ponto cego da clínica.** Atenção e memória quase não aparecem na formação clínica — e, sem eles, a leitura do caso fica limitada por baixo.
- Ψ **A atenção organiza a experiência.** Aquilo a que se atende ganha peso: influencia o que será memorizado, o que emociona e o que se faz. Ela é o primeiro plano da consciência.
- Ψ **Três componentes:** direcionamento, sustentação e flexibilidade. É a modulação entre eles que produz estilos atencionais mais adaptativos ou mais custosos.
- Ψ **A virada da TBP:** a atenção deixa de ser um viés que o paciente “tem” e passa a ser um processo treinável e funcional — o que muda a pergunta de “o que ele tem” para “o que está acontecendo”.
- Ψ **O alvo é a flexibilidade, não a supressão do sintoma.** No caso da dor crônica, ampliar o repertório atencional reduz o sofrimento mais do que tentar apagar a dor.

Por que começar pelos processos básicos

Depois das aulas sobre a crítica à ciência psicológica, o metamodelo, a leitura em rede, a mensuração e a formulação, o encontro abriu a série clínica — e abriu por onde quase ninguém começa. **Processos básicos como atenção e memória são pouco trabalhados na perspectiva clínica**, e a falta deles limita a clínica por baixo: sem entender como a atenção opera, boa parte do que se lê como cognição ou afeto fica sem explicação.

Há também um argumento de arquitetura. Na matriz da TBP, atenção, afeto e biofisiológico aparecem como os componentes mais fundamentais do comportamento humano — os processos sobre os quais os demais se assentam. A atenção é, nesse sentido, um **processo basal de mudança**: mexer nela move o resto da rede.

A PERGUNTA QUE ABRE O TEMA

“Eu não consigo parar de pensar nisso.” É uma das frases mais comuns em consultório — e quase sempre é lida como conteúdo de pensamento. **Ela é, antes disso, um relato atencional.**

Da atenção como recurso à atenção como processo

Uma retrospectiva curta ajuda a situar a virada. A psicologia cognitiva clássica tratava a atenção como **recurso limitado**, algo que se esgota e se divide. A neurociência cognitiva a reorganizou

como **redes atencionais** distribuídas no cérebro. ATCC tradicional a incorporou principalmente pela via dos **vieses** — atenção seletiva à ameaça, por exemplo.

Na TBP ela vira outra coisa: **um processo treinável e funcional**. A diferença não é semântica. Viés é algo que o paciente tem e que se descreve; processo é algo que está acontecendo, que se avalia no contexto e que se modifica. A avaliação fica mais dinâmica, mais contextual, e — o que importa clinicamente — passa a apontar para algo modificável.

Os três componentes

Os processos atencionais regulam **para onde, como e por quanto tempo** a atenção se mantém — e, por essa via, influenciam emoção, cognição e comportamento.

DIRECIONAMENTO

A seleção: para onde a atenção vai, entre tudo o que compete pelo primeiro plano.

SUSTENTAÇÃO

A retenção: por quanto tempo ela permanece ali antes de escapar.

FLEXIBILIDADE

A capacidade de mudar o foco. É o componente mais frequentemente implicado nas dificuldades clínicas.

Estilos atencionais e o custo clínico

A modulação desses três componentes produz estilos — e é no estilo, não no componente isolado, que a clínica costuma esbarrar:

- Ψ **Atenção rígida** — presa a um aspecto, com dificuldade de variação. É o padrão de transtornos somáticos e de boa parte dos quadros ansiosos.
- Ψ **Foco disperso** — dificuldade de sustentar a atenção onde ela precisa ficar.
- Ψ **Atenção deslocada no tempo** — excessivamente voltada ao passado (ruminação) ou ao futuro (preocupação), e por isso ausente do que está acontecendo.

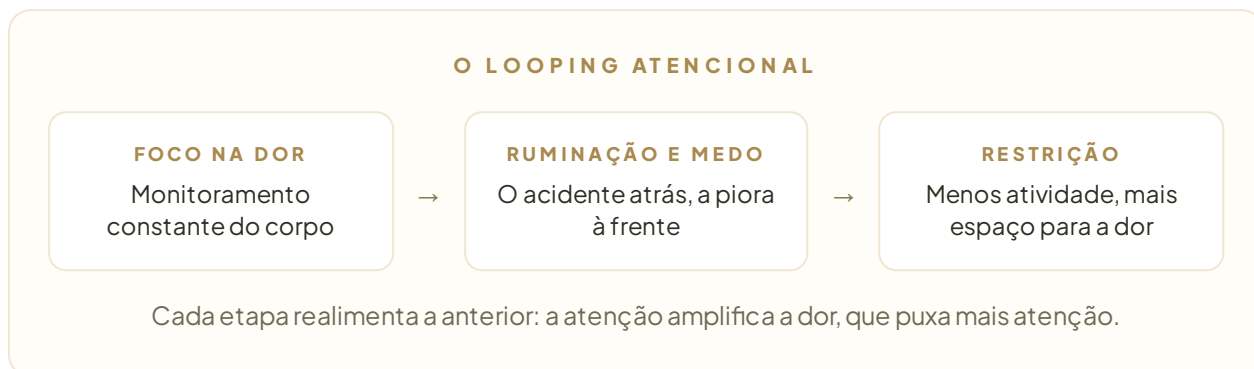
O impacto é sempre na mesma direção: **amplificação do sofrimento e queda da flexibilidade**. E o contraponto adaptativo tem nome — *mindfulness*, entendido aqui de forma precisa e sem misticismo: **atenção flexível somada a agir com consciência**. É esse o estado que as intervenções atencionais buscam.

Maia: o looping atencional na dor crônica

O caso que serviu de fio condutor foi o de Maia, adulta com dor crônica após um acidente de trabalho. Ela restringiu atividades e evita o trabalho por medo da dor. Sente raiva e um senso

agudo de injustiça — havia avisado as chefias sobre o perigo do local antes do acidente — e oscila entre remoer o passado e temer o futuro.

A dor é um estímulo saliente: puxa a atenção sozinha. Mas o que mantém o quadro não é a dor — é o sistema que se organizou em volta dela.



O medo — de piorar, de nova lesão, de incapacidade — aumenta o monitoramento corporal. O monitoramento amplifica a percepção da dor. A dor amplificada alimenta ruminação, irritação e preocupação, que por sua vez restringem atividades e devolvem o foco ao corpo. **O sistema se sustenta sozinho.**

Vale notar o que *não* aparece nessa leitura: um diagnóstico organizando a conduta. Na TBP, a intervenção mira os processos que mantêm o sistema funcionando — não a redução do sintoma como fim em si.

O alvo: flexibilizar, não suprimir

A prioridade da intervenção com Maia é **promover atenção mais flexível e ampliada**, impedindo que o foco se torne exclusivo na dor. Não se trata de distrair nem de negar a dor, e sim de devolver à paciente a possibilidade de alternar focos — o que reabre atividades, melhora a autorregulação e, por consequência, reduz o sofrimento.

É importante ver a ordem aqui: **a redução da dor percebida é efeito, não meta.** Quando a meta é apagar a dor, a própria tentativa vira mais um item do looping.

A SEGUNDA FLECHA

A aceitação da dor reduz sua intensidade percebida — não porque elimine o estímulo, mas porque diminui os processos reativos e cognitivos que o acompanham, ruminação e catastrofização à frente. **Sentir a primeira flecha sem disparar a segunda** evita a amplificação.

Um contraponto interessante apareceu na mediação: em contextos de exercício físico, **focar na dor** tratando-a como processo fisiológico e sem julgamento parece aumentar a tolerância e

prolongar o movimento. Ou seja — não é o direcionamento em si que faz mal, é a função que ele cumpre. Atenção à dor com julgamento e medo amplifica; atenção à dor sem julgamento tolera. [fonte a confirmar — ver nota de método]

Quando a atenção não é o alvo

A aula fechou com um cuidado que evita o excesso de generalização. As intervenções apresentadas foram construídas para o contexto da dor crônica; outros quadros e outros estímulos podem pedir caminhos diferentes — inclusive **estratégias compensatórias** em vez de treino atencional, como costuma ser o caso em contextos neurodivergentes.

A regra permanece a mesma dos encontros anteriores: **a intervenção é modulada pela formulação do caso, não por protocolo**. Dito isso, há uma indicação bastante consistente — pacientes com alta ruminação e preocupação quase sempre pedem trabalho atencional.

E a nota final, na chave de aprendizagem: a terapia se parece com aprender a andar de bicicleta. Exige integração contínua de vários processos — atenção, cognição, comportamento — até que o funcionamento se torne fluido. **O objetivo não é dominar cada peça isoladamente, e sim que elas passem a operar juntas.**

Referências

1. Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., ... Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11(3), 230–241.
2. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment: The conceptual and treatment utility of an extended evolutionary meta-model. *Clinical Psychology Review*, 82, 101908.
3. Hofmann, S. G., Hayes, S. C., & Lorscheid, D. N. (2021). *Learning Process-Based Therapy: A Skills Training Manual for Targeting the Core Processes of Psychological Change in Clinical Practice*. Oakland, CA: New Harbinger. [Ed. bras.: *Aprendendo a Terapia Baseada em Processos*, cap. 6.]
4. McCracken, L. M., & Vowles, K. E. (2014). Acceptance and commitment therapy and mindfulness for chronic pain: Model, process, and progress. *American Psychologist*, 69(2), 178–187.
5. Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Science*, 3(5), 400–424.
6. Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. *Annual Review of Neuroscience*, 35, 73–89.
7. Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience*, 13, 25–42.
8. Sullivan, M. J. L., Bishop, S. R., & Pivik, J. (1995). The Pain Catastrophizing Scale: Development and validation. *Psychological Assessment*, 7(4), 524–532.
9. Vlaeyen, J. W. S., & Linton, S. J. (2000). Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: A state of the art. *Pain*, 85(3), 317–332.

10. Wells, A. (1990). Panic disorder in association with relaxation induced anxiety: An attentional training approach to treatment. *Behavior Therapy*, 21(3), 273–280.

NOTA DE MÉTODO

O caso “Maia” é ilustrativo e foi apresentado como tal em aula. A aula não citou fontes nominalmente: as referências listadas foram acrescentadas por mim como apoio de estudo, cobrindo os pontos tratados — as redes atencionais (Posner & Petersen, 1990; Petersen & Posner, 2012), a ruminação como processo transdiagnóstico (Nolen-Hoeksema et al., 2008), o modelo medo-evitação e a catastrofização na dor crônica (Vlaeyen & Linton, 2000; Sullivan et al., 1995), aceitação e dor (McCracken & Vowles, 2014), a definição operacional de *mindfulness* (Bishop et al., 2004), o treino atencional como técnica (Wells, 1990) e o metamodelo (Hayes et al., 2020). Duas afirmações feitas em aula ficaram marcadas como *[fonte a confirmar]* por terem sido citadas sem identificação de estudo: a de que focar na dor durante exercício físico, sem julgamento, aumenta a tolerância, e a de que a prática longa de atenção plena reduz sensação e percepção de dor. A metáfora das duas flechas é de origem budista e circula amplamente na literatura de terceira onda; foi mantida como metáfora, sem atribuição a um estudo. Sobre vocabulário: a aula usou “atenção, afeto e biofisiológico” como os componentes mais basais da matriz, leitura compatível com a série.

contato@psicojulio.com · (47) 99933-8021

Rua Concórdia, 703, São Vicente, Itajaí — 88309-645 · CNPJ 49.649.803/0001-60

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

- ☐ Perguntei, na avaliação, para onde a atenção do paciente vai — e não só o que ele pensa.
- ☐ Distingui direcionamento, sustentação e flexibilidade em vez de tratar tudo como “desatenção”.
- ☐ Identifiquei o estilo atencional predominante: rígido, disperso ou deslocado no tempo.
- ☐ Mapeei o que realimenta o foco — medo, evitação, ruminação, injustiça — e não só o estímulo.
- ☐ Defini como alvo ampliar a flexibilidade atencional, não suprimir o sintoma.
- ☐ Checei se, neste caso, o trabalho atencional é mesmo o alvo — ou se cabe estratégia compensatória.

MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

1. Por que a atenção é descrita como processo basal — e o que se perde na formulação quando ela é ignorada?

2. Qual a diferença prática entre tratar a atenção como viés e tratá-la como processo treinável?

3. Descreva os três componentes atencionais e dê um exemplo clínico de falha em cada um.

4. No caso de Maia, o que exatamente mantém o looping — e por que reduzir a dor não é a meta?

5. O que significa “sentir a primeira flecha sem disparar a segunda”, em termos de processo?

6. Pegue um paciente seu com alta ruminação: qual componente atencional você trabalharia primeiro, e por quê?